

# ACHIEVE

**Observationele transversale studie om het bereiken van de streefbloeddruk te evalueren in de algemene populatie van hypertensiepatiënten in België behandeld met meerdere antihypertensiva op basis van het type behandeling**

*Exemplaar te bewaren door onderzoeksarts - 1/4*

## Studieprotocol

### 1. Wetenschappelijke rationale

Hypertensie is nog steeds een belangrijke doodsoorzaak en één van de voornaamste beïnvloedbare risicofactoren voor cardiovasculaire, cerebrovasculaire en renovasculaire aandoeningen.

Ondanks de impact van deze ziekte op de volksgezondheid en de kosten van de zorg wordt de ziekte in veel gevallen niet opgemerkt en is de behandeling suboptimaal. Volgens schattingen is bij de helft van de patiënten de hypertensie niet gekend, is bij ten minste de helft van de behandelde patiënten de bloeddruk niet onder controle en is de helft van de patiënten die behandeld worden met antihypertensiva op lange termijn niet therapietrouw. Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de vroegtijdige diagnose en adequate behandeling van hypertensie.

Naast de niet-farmacologische maatregelen om hypertensie te voorkomen en te behandelen wordt in de recente aanbevelingen van de European Society of Hypertension en de European Society of Cardiology van 2013<sup>(1)</sup> aangeraden om snel met een farmacologische behandeling te beginnen. Voor de behandeling van hypertensie worden de geneesmiddelenklassen gebruikt die momenteel beschikbaar zijn, dat wil zeggen thiazidediuretica, bètablokkers, calciumantagonisten, ACE-remmers en angiotensinereceptorantagonisten.

In de aanbevelingen wordt ook benadrukt dat het belangrijk en noodzakelijk is om snel meerdere antihypertensiva te combineren bij de meerderheid van de hypertensiepatiënten. Er wordt gesteld dat een monotherapie slechts doeltreffend is bij een beperkt aantal patiënten en dat een bitherapie doeltreffender is dan een hooggedoseerde monotherapie (vooral bij patiënten met ernstige hypertensie of een hoog cardiovasculair risico). Als de bitherapie faalt of onvoldoende effect heeft, adviseert het aanbevolen therapeutisch algoritme vervolgens om de dosering van de oorspronkelijke bitherapie te verhogen of een andere bitherapie of een tritherapie voor te schrijven.

Bij gebruik van een bi- of tritherapie wordt in de Europese aanbevelingen de voorkeur gegeven aan één inname per dag, omdat beperking van het aantal innames per dag en van het aantal tabletten bevorderlijk is voor de therapietrouw en de bloeddrukcontrole.

In België zijn er weinig epidemiologische gegevens over de huidige behandeling van hypertensie en de manier waarop de huisartsen deze recente aanbevelingen in de praktijk toepassen. Met deze studie proberen we deze situatie te verhelpen.

### 2. Doelstelling

Het doel van deze studie is te evalueren in welke mate in de huidige praktijk van huisartsen in België de streefbloeddruk wordt bereikt bij hypertensiepatiënten die behandeld worden met meerdere antihypertensiva en dat volgens het type behandeling.

In de studie willen we met name de mate van bloeddrukcontrole evalueren op basis van:

- het aantal gebruikte antihypertensiva (twee of drie)
- de verschillende associaties van antihypertensiva
- het type associatie (vrij of vast, aanbevolen of niet)

#### Verwachte toegevoegde waarde

Door deze studie uit te voeren zullen we:

- een beter idee hebben van de reële doeltreffendheid van de associatie van meerdere antihypertensiva als behandeling voor hypertensie in de huidige klinische praktijk
- de lacunes in de therapeutische benadering van deze patiënten kunnen bepalen
- acties kunnen voorstellen om de bloeddrukcontrole te verbeteren

### 3. Opzet

Dit is een observationele transversale studie (cross-sectional survey).

Het studieontwerp heeft de volgende kenmerken:

- Enkel de bestaande gegevens die gewoonlijk worden geregistreerd in de dagelijkse praktijk, worden verzameld. Deze routinegegevens worden niet specifiek verzameld om het doel van de studie te bereiken.
- De gegevens worden op één bepaald moment verzameld, zodat we een transversaal overzicht krijgen van de bestudeerde populatie. De studie zal zich beperken tot de huidige situatie (in 2015).
- Het is een zuiver beschrijvende studie (de statistische analyse kan de huidige situatie beschrijven). De ontwikkeling van deze situatie in de loop der tijd wordt niet onderzocht (dat is alleen mogelijk met een longitudinale studie).

De studie zal de gestelde vragen perfect kunnen beantwoorden.

Deze studie, die uitgaat van beschikbare gegevens en geen inbreng vraagt van de betreffende patiënten, wordt beschouwd als 'retrospectief' in de zin van paragraaf 1.4 van de Leidraad voor niet-interventionele studies van mei 2008<sup>(2)</sup>. De wet inzake experimenten op de menselijke persoon (7 mei 2004) is dus niet van toepassing. In deze context heeft het Visumbureau van pharma.be een voorafgaand visum verstrekt voor de studie, op basis van de aanbevelingen in de Deontologische code (23 maart 2012).

### 4. Patiënten en onderzoeksartsen

#### 4.1 Patiënten

De patiënten waarop de studie betrekking heeft, zijn hypertensiepatiënten die al behandeld worden met meerdere antihypertensiva en bij een huisarts op spreekuur komen in België.

Het aantal patiënten, waarvan de gegevens zullen verzameld worden, wordt geschat op 5.000.

Dit aantal is niet gebaseerd op een statistische berekening –wat inherent is aan het gebruikte type studieontwerp - maar komt overeen met de gebruikelijke steekproefgrootte voor dit soort epidemiologisch onderzoek.

#### 4.2 Onderzoeksartsen

De studie richt zich op huisartsen die hun praktijk hebben in België en die dit type patiënten regelmatig zien op hun spreekuur.

Het aantal artsen dat noodzakelijk is om de gegevens van 5000 patiënten te verzamelen wordt geschat op 420, waarbij elke huisarts de gegevens verzamelt van 12 patiënten die in aanmerking komen voor de studie en die hij/zij op spreekuur ziet. Deze huisartsen worden gerekruteerd over heel België, met een evenwichtige geografische spreiding, in een periode van 4 maanden (19 januari 2015 tot 19 mei 2015). Op die manier kunnen de artsenbezoekers van Servier Benelux afspraken plannen met de onderzoeksartsen voor het eerste bezoek, hun toestemming voor deelname verkrijgen, het contract laten ondertekenen en het nodige materiaal voor de studie overhandigen.

Om selectiebias te voorkomen wordt aan de onderzoeksartsen gevraagd om de laatste 12 opeenvolgende patiënten op te nemen die voldoen aan de studiecriteria en die ze onlangs op spreekuur hebben gezien.

## 5. Verzamelde gegevens

Voor elke patiënt die in aanmerking komt, noteert de onderzoeksarts de volgende bestaande gegevens op een observatieformulier:

- het nr. van de patiënt in de studie (van 1 tot 12), zijn leeftijd en geslacht
- hypertensie: gecompliceerd (diabetes, cardiovasculaire antecedenten, nierinsufficiëntie) of niet, aantal ingenomen antihypertensiva
- systolische/diastolische bloeddruk (mmHg), onder controle geacht of niet
- behandeling met medicijnen: gebruikte antihypertensiva, dosering, type associatie (vrij of vast)
- reden voor de gekozen therapie

Naast de patiëntgegevens staan op het observatieformulier ook de naam van de onderzoeksarts, diens adres, handtekening en stempel, om zo nodig contact op te kunnen nemen en als garantie van authenticiteit.

Op het observatieformulier staan ook het visumnummer van pharma.be en de naam van de contactpersoon bij Servier Benelux, zodat de onderzoeksarts zo nodig aanvullende informatie kan opvragen.

De benodigde gegevens voor de studie worden verzameld in een periode van 3 maanden na de toestemming van de onderzoeksarts om deel te nemen aan de studie, zodat deze drukbezette huisartsen de tijd hebben om de 12 patiënten die in aanmerking komen voor de studie te bepalen en de bijbehorende observatieformulieren in te vullen. Daarna hebben de artsenbezoekers van Servier Benelux 2 maanden de tijd om de observatieformulieren in te zamelen. Aangezien de uiterste datum voor het rekruteren van onderzoeksartsen 19 mei 2015 is, zouden alle verzamelde gegevens beschikbaar moeten zijn op 19 augustus 2015, de einddatum van de studie.

Als de onderzoeksarts gegevens voor de studie zoekt in het patiëntendossier en daarbij op een bijwerking stuit die mogelijk verband houdt met het gebruik van een geneesmiddel van Servier Benelux en die (nog) niet is gerapporteerd aan Servier Benelux, wordt hij/zij verzocht dat zo spoedig mogelijk te doen door het formulier voor Rapportering van bijwerking onmiddellijk te verzenden naar de verantwoordelijke voor farmacovigilantie bij Servier Benelux, Dr. Xavier Pottier (fax: 02/529.43.89, e-mail: [pharmacovigilance@be.netgrs.com](mailto:pharmacovigilance@be.netgrs.com), tel: 02/529.43.11).

Tevens wordt aan de onderzoeksarts gevraagd alle bijzondere situaties met betrekking tot een geneesmiddel van Servier Benelux te rapporteren aan Servier Benelux, namelijk:

- elke bijwerking die tot de stopzetting van de behandeling heeft geleid,
- elke vermoedelijke overdracht van een infectie via een geneesmiddel,
- elke overdosering (opzettelijk of per ongeluk), misbruik of verkeerd gebruik,
- elk gebruik buiten indicatie (off-label),
- elke medicatiefout,
- elk gebrek aan een verwacht farmacologisch effect (gebrek aan werkzaamheid) voor producten gebruikt voor mogelijks dodelijke ziekten op korte termijn,
- elke blootstelling aan een geneesmiddel tijdens zwangerschap of borstvoeding,
- elke professionele blootstelling,
- elke bijwerking door een kwaliteitsgebrek of namaak.

Om bijzondere situaties met betrekking tot een geneesmiddel van Servier Benelux te rapporteren dient tevens het formulier voor Rapportering van bijwerkingen gebruikt te worden.

Indien nodig zal de verantwoordelijke voor farmacovigilantie van Servier Benelux contact opnemen met de onderzoeksarts om meer informatie in te winnen.

In geval van bijwerkingen met een ander geneesmiddel, raden wij u aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hiervan op de hoogte te brengen via de site [www.fagg-afmps.be](http://www.fagg-afmps.be) of de houder van de vergunning van het geneesmiddel.

## 6. Analyse van de resultaten

Na een kwaliteitscontrole worden de gegevens van alle correct ingevulde observatieformulieren ingevoerd in een Excel-tabel om de volgende beschrijvende statistische analyses te kunnen uitvoeren:

- studiepopulatie: aantal patiënten, verdeling op basis van leeftijd en geslacht, percentage patiënten met gecompliceerde hypertensie, verdeling op basis van het aantal gebruikte antihypertensiva
- bloeddruk: systolisch en diastolisch (totale populatie versus risicopopulatie), percentages goede bloeddrukcontrole (totaal versus risicopatiënten, op basis van de ernst van de hypertensie, op basis van het aantal gebruikte antihypertensiva, op basis van de verschillende associaties van antihypertensiva en op basis van het type associatie)
- behandeling met medicijnen: verdeling op basis van het aantal gebruikte antihypertensiva, de verschillende gebruikte associaties, het type associatie (vrij of vast, aanbevolen of niet), reden voor gekozen therapie

De dienstverlener PharmaCS (Heirbaan 26, 1785 Merchtem) zal de gegevens beheren en de statistische analyses uitvoeren, onder toezicht van de wetenschappelijke dienst van Servier Benelux.

## 7. Studieverslag en publicatie

Na analyse van de gegevens en interpretatie van de resultaten wordt een studieverslag opgesteld door PharmaCS (Heirbaan 26, 1785 Merchtem) en goedgekeurd door de wetenschappelijke dienst van Servier Benelux. Er is ook een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift gepland.

Dit verslag (of deze publicatie) wordt verzonden naar alle onderzoeksartsen die hebben deelgenomen aan de studie en wordt ook ter beschikking gesteld van de organen van pharma.be vermeld in artikel 52, § 1 van de Deontologische code van 23 maart 2012.

## 8. Kwaliteitsbeheer

Het studieprotocol is opgesteld in samenwerking met de wetenschappelijke dienst van Servier Benelux, die het heeft goedgekeurd en die toeziet op het goede verloop van de studie.

Het Visumbureau van pharma.be heeft een voorafgaand visum verstrekt voor de studie, op basis van de aanbevelingen in de Deontologische code (23 maart 2012).

Om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te controleren vindt er een kwaliteitscontrole plaats, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteitsrisico's die inherent zijn aan de methodologie van deze observationele studie. Daarvoor zal de wetenschappelijke dienst van Servier Benelux bij wijze van steekproef 5% van de observatieformulieren van de onderzoeksartsen die hebben deelgenomen aan de studie, verifiëren.

PharmaCS (Heirbaan 26, 1785 Merchtem) beheert de gegevens, voert de statistische analyses uit en stelt het studieverslag op, onder toezicht van de wetenschappelijke dienst van Servier Benelux.

De rol van de artsenbezoekers van Servier Benelux blijft beperkt tot de twee volgende acties:

- eerste bezoek: voorstelling van de studie, overhandiging van het protocol en observatieformulier, ondertekening van het contract met de onderzoeksarts
- afsluitend bezoek: ophaling van de ingevulde observatieformulieren

## 9. Referenties

1. Mancia G, Fagard R et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2013, 31: 1281-1357.
2. Bogaert M et al. Guide d'évaluation des études non interventionnelles. [http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/recherche\\_developpement/comite\\_d\\_ethique/](http://www.fagg-afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/recherche_developpement/comite_d_ethique/)

## 10. Handtekeningen

### ONDERZOEKSARTS

Naam: .....

Handtekening:

### SERVIER BENELUX

Naam: Pauwels Valerie

Handtekening:



| Patiënt | Datum van gegevens-verzameling (dd/mm/jjjj) | Leeftijd (jaar) | Geslacht (M/V) | Gecompleceerde hypertensie?                                                                                                                                                                        | SBD/DBD (mmHg) | Patiënt onder controle?                                                        | Huidige anti-hypertensieve behandeling:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 2       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 3       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 4       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |

| Patiënt | Datum van gegevens-verzameling (dd/mm/jjjj) | Leeftijd (jaar) | Geslacht (M/V) | Gecompleceerde hypertensie?                                                                                                                                                                        | SBD/DBD (mmHg) | Patiënt onder controle?                                                        | Huidige anti-hypertensieve behandeling:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 6       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 7       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 8       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b><br/>(Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden?<br/>(meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |

| Patiënt | Datum van gegevens-verzameling (dd/mm/jjjj) | Leeftijd (jaar) | Geslacht (M/V) | Gecomplceerde hypertensie?                                                                                                                                                                         | SBD/DBD (mmHg) | Patiënt onder controle?                                                        | Huidige anti-hypertensieve behandeling:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden? (meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 10      |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden? (meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 11      |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden? (meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |
| 12      |                                             |                 |                | <div><input type="checkbox"/> Diabetes</div> <div><input type="checkbox"/> CV antecedenten</div> <div><input type="checkbox"/> Nierinsufficiëntie</div> <div><input type="checkbox"/> Andere</div> |                | <div><input type="checkbox"/> Ja</div> <div><input type="checkbox"/> Nee</div> | <div><b>Vrije associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div><b>Vaste associatie:</b> (Product / Dosis)</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> <div>..... / .....</div> | <div>Als de patiënt geen vaste associatie van twee of drie producten neemt, overweegt u dan om over te schakelen op</div> <div><b>een vaste bitherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div><b>een vaste tritherapie:</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee</div> <div>Zo ja, om welke reden? (meerdere keuzes mogelijk)</div> <div><input type="checkbox"/> Betere therapietrouw</div> <div><input type="checkbox"/> Betere bloeddrukcontrole</div> <div><input type="checkbox"/> Betere prognose</div> <div><input type="checkbox"/> Andere :</div> |

In geval van bijwerkingen of elke bijzondere situatie met een geneesmiddel, gelieve paragraaf 5 van het studieprotocol te raadplegen.

# ACHIEVE

Cross-sectional survey evaluating blood pressure target **ACHIEVE**ment in the Belgian general hypertensive population treated with multiple anti-hypertensive agents according to the treatment received

ACHIEVE IC4-06593-012-BEL  
Observatieformulier goedgekeurd d.d. 25/11/14 - BN 15 TM C2 BI LP 01  
Visa Pharma.be: VI 14/10/06/01 verkregen d.d. 16/10/2014

Observationele transversale studie om het bereiken van de streefbloeddruk te evalueren in de algemene populatie van hypertensiepatiënten in België die behandeld worden met meerdere antihypertensiva en dat volgens het type behandeling

Contactpersoon Servier: .....

Naam onderzoeksarts: .....

Adres: .....

.....

Handtekening:

Stempel